Malformations du pied et pied bot varus équin

Le cours reconstruit à partir des QCM : ce qui est demandé, les pièges, et seulement l'essentiel du cours.

Comment lire ce cours

TOMBE EN QCM signale un point déjà posé en QCM ; ×N = nombre de fois où il apparaît dans la banque et le recueil corrigé (doublons entre sessions inclus, ordre de grandeur). Priorité : ★★★ ≥ 10 questions, ★★ 5 à 9, ★ moins de 5.

✔ = proposition juste · ✘ = proposition fausse (les pièges). Les encadrés rouges signalent les contradictions entre le cours, la banque et le corrigé.

À propos du contenu

- Le cours (8 pages) porte sur les malpositions et malformations du pied du nouveau-né, avec le **pied bot varus équin (PBVE)** comme sujet central, puis le pied convexe, le pied en Z, le métatarsus adductus, le pied talus et les malformations des orteils.
- La banque va au-delà du cours : elle teste surtout les **angles radiographiques du PBVE**, la **classification de Swanson** des malformations de membres et la **maladie amniotique**. Ces sujets ne sont pas dans votre PDF de cours ; je les ai ajoutés à partir des QCM et de leurs corrections, signalés « hors cours ».
- Environ **10 QCM** sont classés dans le chapitre « Malformations congénitales du pied » et une quarantaine d'autres, répartis dans des chapitres voisins (hanche luxante, scoliose, coude), portent sur les mêmes sujets.

Les 10 points à connaître avant tout

1. Le PBVE est une **urgence orthopédique néonatale** : traitement dès les premiers jours, idéalement la **1re semaine de vie**. Jamais « attendre l'âge de la marche ».
2. Triade : **équin + varus** de l'arrière-pied, **adduction** de l'avant-pied (supination selon le cours). **Le talus n'en fait jamais partie**.
3. Traitement de choix : **méthode de Ponseti** (plâtres successifs + **ténotomie du tendon d'Achille**). Fonctionnel (kinésithérapie) et chirurgical existent ; pas de traitement « médical ». La chirurgie vient en 2e recours.
4. Radio de **face** : divergence talo-calcanéenne **diminuée**, angle talus-M1 **augmenté**, angle calcanéum-M5 **augmenté**. Profil : angle tibio-talien **augmenté** (équin).
5. PBVE : le plus souvent **idiopathique**, **bilatéral dans 49 %**, **garçons 70 %** ; secondaire (10 %) à une maladie neuromusculaire ou un syndrome polymalformatif ; gravité par le **score de Dimeglio** sur 20.
6. **Malformation** (anomalie irréversible, trouble intrinsèque, avant la fin de la période embryonnaire, traitement nécessaire) ≠ **déformation / malposition** (contrainte extrinsèque, se corrige seule).
7. **Métatarsus adductus** : la plus fréquente des déformations ; avant-pied dévié en dedans, **arrière-pied normal** ; contrainte intra-utérine ; régresse le plus souvent. **Pied talus** : corrige avant le 4e mois.
8. **Pied convexe congénital** : rare mais grave, luxation dorsale fixée du naviculaire, équin irréductible, pied « en bateau ».
9. **Swanson** : I formation · II différenciation · III duplication · IV hypertrophie · V hypotrophie · VI **brides amniotiques** · VII syndromes. Maladie amniotique : **sillons**, amputations, acrosyndactylie.
10. Le PBVE et les malformations du pied font rechercher une **hanche à risque** (luxation congénitale de hanche).

Ce qui tombe le plus

Thème	Fréquence	Priorité
Swanson et malformations de membres (ectromélie, phocomélie)	≈ 11	★★★
Maladie amniotique (brides, sillons, acrosyndactylie)	≈ 9	★★
PBVE : composantes de la déformation, urgence, définition	≈ 8	★★
PBVE : traitement (Ponseti, fonctionnel, chirurgie)	≈ 8	★★

Thème	Fréquence	Priorité
PBVE : angles radiographiques de face et de profil	≈ 8	★★
Pied bot : quels pieds regroupe-t-on ?	≈ 2	★
Hanche à risque et malformation des pieds	≈ 3	★
Urgences orthopédiques néonatales	≈ 2	★
Métatarsus adductus et prise en charge générale (EMD 2025/2026)	≈ 2	★
Syndactylie de la main, appui normal du pied, pied talus	≈ 1–2 chacun	★

1 · Principes : malpositions, déformations, malformations TOMBE EN QCM ×4 ★

Le pied du nouveau-né peut présenter plusieurs anomalies, parfois dépistées en anténatal. L'essentiel est de **distinguer les malpositions bénignes** (évolution favorable) des **malformations sévères** qui nécessitent une prise en charge spécialisée. Le PBVE occupe une place à part par son **traitement codifié et standardisé**. Le dépistage anté puis néonatal est la base de la prise en charge.

Terme	Définition (cours)	Exemples
Malformation	Anomalie congénitale **irréversible** de la formation d'un tissu, due à des troubles **intrinsèques** survenant avant la fin de la période embryonnaire ; **nécessite un traitement**	PBVE, pied convexe congénital (PCC), pied en Z
Déformation	Problème de position dû à des facteurs **extrinsèques** ; **se corrige spontanément**	Pied talus, métatarsus adductus
Malposition	Résulte des contraintes intra-utérines (cohabitation difficile entre mouvement, croissance du fœtus et paroi utérine)	Mêmes exemples que les déformations

Examen : dès le 1er jour, en salle d'accouchement, **uniquement clinique** (l'imagerie n'a pas de place à ce stade). Interrogatoire : antécédents familiaux, grossesse (position, infection, primiparité), accouchement, déformation présente dès la naissance, évolution, traitement. Examen général à la recherche d'une autre malformation (tête, cou, membres supérieurs, dos, **hanches**, membres inférieurs), d'une hyperlaxité, examen neurologique. Examen local : nombre et taille des rayons, segmentation des orteils, plis anormaux, position spontanée du pied, mobilité, paralysie, parties molles, **réductibilité** des déformations, reliefs des malléoles.

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×3 **Déformations et pied normal**

- ✔ Appui normal du pied : **tête du 1er métatarsien**, **tête du 5e métatarsien** et **grosse tubérosité du calcanéum** (tripode de Broca)
- ✔ Pied bot = **pied varus équin** et **pied convexe** (dans une version de la banque)
- ✘ Appui par le talus ou par la tête des 5 métatarsiens
- ✘ Pied plat et pied creux comme pieds bots
- ✘ Les déformations congénitales nécessitent le plus souvent une prise en charge urgente

Une question de la banque affirme que les « déformations congénitales » surviennent en vie embryonnaire et résultent d'un trouble de l'organogenèse : c'est la définition d'une malformation dans le cours. Cochez-la telle quelle si elle apparaît.

2 · Rappel embryologique (peu interrogé)

Repère	Valeur
28e jour	Bourgeon du membre inférieur
33e jour	Première ébauche du pied
57e jour (8 SA)	Pied en **équin-supination** (4,5 mm) ; plantes face à face ; la croissance dépend du mouvement
Après la 10e semaine	Équin, varus et adduction diminuent par **rotation médiale** ; position neutre à **11 semaines**
Ossification	Métatarsiens à 3–4 mois ; calcanéum 4e mois ; astragale 7e mois (selon le cours)
À la naissance	Pied de 7,5 cm, ossifié à **25 %** ; à 18 mois = 50 % du pied adulte

Le PBVE ressemble donc à un pied d'embryon de 8 semaines figé : c'est une persistance de la position fœtale précoce.

3 · Le pied bot varus équin (PBVE) TOMBE EN QCM ×16 ★★★

	À retenir
Définition	Pied déformé dans les **3 plans de l'espace** : **varus et équin de l'arrière-pied**, **adduction et supination de l'avant-pied**
Réductibilité	Le cours dit « non réductible par manœuvre externe » ; en pratique la réductibilité varie à la naissance (voir pièges)
Étiologie	Le plus souvent **idiopathique** ; **secondaire dans 10 %** (maladies neuromusculaires, syndrome polymalformatif)
Épidémiologie	**Bilatéral dans 49 %** ; **prédominance masculine 70 %**
Gravité	**Score de Dimeglio** sur **20 points**
Nature	**Urgence orthopédique néonatale** : traitement dès la naissance

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×16 **PBVE : définition, composantes, urgence**

- ✔ Associe **équin**, **varus** et **adduction** (le cours ajoute la supination de l'avant-pied)
- ✔ Déformation présente **dès la naissance**
- ✔ **Urgence orthopédique néonatale** / urgence thérapeutique
- ✔ Son traitement est **orthopédique** ; il peut être **chirurgical** (en 2e recours)
- ✔ La **radio de profil** montre l'équinisme
- ✔ Fait partie des urgences orthopédiques néonatales avec le torticolis congénital musculaire, les syndactylies embryonnaires et l'ostéo-arthrite du nouveau-né
- ✔ PBVE ou malformation des pieds → **rechercher une luxation congénitale de hanche** (hanche à risque)
- ✘ **Talus** comme composante du PBVE
- ✘ Valgus de l'arrière-pied
- ✘ Est irréductible à la naissance
- ✘ Est une urgence thérapeutique : fausse dans une session, vraie dans les autres (voir pièges)
- ✘ Sans traitement, est **toujours** chirurgical
- ✘ Scoliose idiopathique parmi les urgences néonatales
- ✘ Le PBVE comme « malformation du pied » (la banque la marque fausse : c'est une déformation)

Question « sauf une » sur la triade : selon l'énoncé, la réponse est talus ou, dans certaines sessions, supination ; lisez les options.

PIÈGES

Malformation ou déformation ? Votre cours range le PBVE parmi les **malformations** (avec PCC et pied en Z) ; la banque marque « le PBVE est une malformation du pied » **faux** (il s'agit d'une déformation, définition de Broca). Si l'énoncé est sous cette forme, suivre la banque.

Supination. Le cours inclut la supination de l'avant-pied. Les clés officielles de plusieurs sessions la tiennent pour fausse (« équin, varus, adduction »), et une question « sauf une » a la supination pour réponse. Le **talus** reste toujours faux.

Urgence. Une session a coché « urgence thérapeutique » faux ; le corrigé précise que le cours affirme « urgence orthopédique » et que les autres sessions la retiennent vraie. Retenir : **vraie**.

Irréductible. Les QCM marquent « irréductible à la naissance » faux : la réductibilité est variable (bien réductible, partiellement, raide).

4 · Radiographie du PBVE (hors cours, très interrogée) TOMBE EN QCM ×8 ★★

Votre cours indique que l'imagerie n'a pas de place à l'examen du nouveau-né ; la banque teste pourtant les angles du pied bot sur les radiographies. Principe : **l'adduction du bloc calcanéo-pédieux rapproche l'astragale et le calcanéum** (ils deviennent parallèles).

Incidence	Angle	Dans le PBVE	Ce que cela traduit
Face	Divergence talo-calcanéenne (astragalo-calcanéenne)	**Diminuée**	Adduction du bloc calcanéo-pédieux / varus du calcanéum
Face	Angle talus – 1er métatarsien (normal 10–15°)	**Augmenté**	Adduction de l'avant-pied
Face	Angle calcanéum – 5e métatarsien (≈ rectiligne)	**Augmenté**	Adduction médio-tarsienne / Lisfranc
Profil	Angle tibio-talien (normal 90°)	**Augmenté**	Équinisme
Profil	Angle tibio-calcanéen	**Augmenté**	Équin sévère : au-delà de 80°, ténotomie d'Achille (selon le corrigé)
Profil	Divergence talo-calcanéenne (normale 40–50° chez le petit enfant)	**Diminuée**	Adduction du bloc calcanéo-pédieux

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×8 **Angles radiographiques**

- ✓ **Face** : divergence talo-calcanéenne **diminuée**, angle talus-M1 **augmenté**, angle calcanéum-M5 **augmenté**
- ✓ **Profil** : angle tibio-talien **augmenté**, divergence talo-calcanéenne **diminuée**, angle tibio-calcanéen **augmenté**
- ✓ Angles de profil du pied bot : divergence astragalo-calcanéenne, angle tibio-astragalien (et tibio-calcanéen)
- ✓ Sur une face stricte, la diminution de la divergence talo-calcanéenne témoigne du **varus du calcanéum**
- ✘ Divergence talo-calcanéenne **augmentée**
- ✘ Angle talus-M1 diminué
- ✘ Angle tibio-talien diminué · angle tibio-calcanéen diminué
- ✘ Angle astragale-1er métatarsien et angle calcanéum-5e métatarsien comme angles de **profil** (ce sont des angles de face)
- ✘ Diminution de la divergence = adduction de l'avant-pied ou équinisme (selon la clé de la banque)

Les angles de face = ceux qui touchent l'avant-pied (M1, M5). Ceux de profil = l'équin (tibio-talien, tibio-calcanéen) et la divergence talo-calcanéenne.

PIÈGES

« Les angles de profil ». La banque présente deux versions de la même question. La clé de l'examen retient parfois seulement « tibio-astragalien » et « astragale-calcanéum » ; le corrigé relève l'incohérence (divergence astragalo-calcanéenne et angle astragale-calcanéum désignent le même angle) et conclut : **divergence, tibio-astragalien, astragale-calcanéum**. Une des versions de la banque n'a pas de clé.

Face : à quoi correspond la diminution de la divergence ? Clé de la banque : « varus du calcanéum » ; le corrigé la rattache à l'adduction du bloc calcanéo-pédieux. Les deux décrivent le même phénomène ; choisir selon les options proposées.

5 · Traitement du PBVE TOMBE EN QCM ×8 ★★

But : obtenir un **pied plantigrade** : correction des déformations, stabilisation de la correction, équilibre musculaire, liberté articulaire. Idéalement, la prise en charge commence **dès la première semaine de vie**.

Méthode	Contenu (cours)	Place
Fonctionnelle	Kinésithérapie : manipulations qui corrigent les différentes déformations	Utilisable, mais « difficile » dans les formes sévères (grade 4 de Dimeglio)
Orthopédique : Ponseti	Période néonatale : **série de plâtres** qui corrigent les déformations, complétée par une **ténotomie du tendon d'Achille**	**Méthode de référence**, y compris dans les formes sévères
Chirurgicale	**Temps postéro-interne** : libération des parties molles	**2e recours** après échec du traitement orthopédique ; jamais d'emblée

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×8 **Traitement du PBVE**

- ✔ Le traitement fait appel au **traitement chirurgical**, à la **méthode fonctionnelle** et à la **méthode de Ponseti**
- ✔ PBVE de **grade 4 de Dimeglio** à la période néonatale : c'est une **urgence orthopédique** et la **méthode de Ponseti** est l'indication de choix
- ✔ Prise en charge des malformations du pied : traitement **orthopédique en 1re intention** ; PBVE idiopathique pris en charge dès les **premières semaines** ; la **compliance familiale** est un facteur majeur de succès
- ✘ **Traitement médical** (aucun médicament ne corrige le PBVE)
- ✘ Toutes les propositions sont justes (quand « médical » est dans la liste)
- ✘ Traitement chirurgical **d'emblée** · attendre l'âge de la marche puis opérer
- ✘ La chirurgie est **toujours** indiquée après un échec partiel du traitement orthopédique
- ✘ Les attelles et plâtres sont inutiles après l'âge de la marche

Complément hors cours : le Ponseti se poursuit par une orthèse de maintien, d'où le poids de la compliance familiale. Score de Dimeglio : grade I < 5, II 5–9, III 10–14, IV 15–20 ; le grade 4 est un pied raide, peu réductible.

6 · Les autres malformations et déformations du pied TOMBE EN QCM ×5 ★★

Entité	Type	Points clés (cours)
Pied convexe congénital (PCC)	Malformation, rare mais **grave**	Idiopathique dans ½ des cas ; secondaire à une arthrogrypose ou un spina bifida. **Luxation dorsale fixée du naviculaire** ; équin irréductible de l'arrière-pied, avant-pied en flexion dorsale ; plante convexe (**pied en bateau**). Traitement orthopédique ou chirurgical (cas sévères)
Pied en Z (serpentin)	Malformation, rare	Adduction angulaire du médio-avant-pied, proche du métatarsus adductus, avec **bosse dorso-latérale** ; traitement orthopédique (plâtres, attelles, kinésithérapie)
Métatarsus adductus	Déformation, la **plus fréquente**	4–13 % dépistés à la naissance ; **60 % bilatéraux** ; évolution favorable ; traitement le plus souvent orthopédique. **Avant-pied dévié en dedans, arrière-pied normal**
Pied talus	Déformation	**Flexion dorsale exagérée** du pied ; **correction spontanée avant le 4e mois** ; évolution favorable

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×5 **Métatarsus adductus et prise en charge**

- ✔ Déviation **médiale de l'avant-pied** avec **arrière-pied normal**
- ✔ Liée le plus souvent à une **contrainte intra-utérine**
- ✔ La majorité des formes sont **souples** et **régressent spontanément**
- ✘ Fréquemment associé à un PBVE
- ✘ Traitement chirurgical d'emblée

Question EMD 2025/2026 : les trois premières propositions sont justes ; les deux dernières sont fausses.

PIÈGES

Quels pieds sont des « pieds bots » ? Deux versions : (a) PBVE et **pied convexe** justes ; talus, plat, creux faux ; (b) PBVE, **métatarsus adductus**, **pied talus**, **pied convexe** justes ; pied valgus faux. Votre cours range pourtant talus et métatarsus adductus parmi les déformations bénignes. Lisez les options : la présence de « pied plat », « pied creux » ou « pied valgus » signale toujours une proposition fausse.

7 · Malformations des orteils TOMBE EN QCM ×3 ★

Anomalie	Définition	Chiffres et conduite
Syndactylie	Défaut de creusement de la commissure entre deux rayons ; complète ou incomplète, simple ou complexe	Fréquente, souvent familiale. Chirurgie pour la **1re commissure après l'acquisition de la marche** ; autres commissures : esthétique
Clinodactylie	Défaut d'orientation (inclinaison + rotation)	Surtout le **5e orteil** qui passe au-dessus du 4e ; bilatérale dans 25 % ; familiale
Brachydactylie	Défaut de longueur	Très rare ; 3e et 4e rayons ; pas de gêne fonctionnelle
Agénésie (ectromélie)	Absence d'un ou plusieurs rayons	Rayons centraux, médial, latéral ou distal
Polydactylie	Excès du nombre d'orteils	1/1000 chez les Caucasiens, 10/1000 chez les Noirs ; bilatérale symétrique 50 % ; familiale 30 % ; **postaxiale 70 %**, préaxiale 30 % ; gêne au chaussage
Macrodactylie	Excès de volume d'un ou plusieurs rayons	Très rare ; isolée ou syndromique ; pieds ou mains

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×3 **Syndactylie (main) et orteils**

- ✔ Syndactylie de la main : **séparer rapidement la 1re commissure**
- ✔ Peut exister en cas de **maladie amniotique**
- ✔ Les syndactylies embryonnaires font partie des urgences orthopédiques néonatales
- ✔ Doigt surnuméraire : signe d'appel d'une hanche à risque dans un cas clinique
- ✘ Syndactylie = défaut de séparation **transversal**
- ✘ Peut causer des troubles neurologiques
- ✘ Syndactylie + agénésie du grand pectoral = syndrome de Claude Bernard-Horner (c'est le syndrome de Poland)

Retenir la différence : syndactylie de main → séparation rapide de la 1re commissure ; syndactylie d'orteils → après la marche, esthétique pour les autres commissures.

8 · Malformations des membres : Swanson et maladie amniotique (hors cours) TOMBE EN QCM ×20 ★★★

Le thème le plus répété de la banque après le PBVE. La classification de **Swanson** range les malformations de membres en 7 types.

Type	Défaut	Exemple
I	Défaut de **formation** (arrêt de développement)	Agénésie, ectromélie longitudinale ou transversale
II	Défaut de **différenciation** (séparation)	Syndactylie, synostose
III	**Duplication**	Polydactylie, duplication du pouce
IV	**Hypertrophie** (surdéveloppement, gigantisme)	Macrodactylie
V	**Hypotrophie** (sous-développement)	
VI	**Maladie (syndrome) des brides amniotiques**	Sillons, amputations, acrosyndactylie
VII	Anomalies squelettiques généralisées / grands syndromes	

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×6 **Swanson**

- ✔ Type **III** : duplication
- ✔ Type **IV** : hypertrophie (surdéveloppement, gigantisme)
- ✔ Type **VI** : maladie amniotique
- ✔ Type I (défaut de formation) → le type amniotique pose son diagnostic différentiel avec lui
- ✘ Type V = maladie amniotique
- ✘ Type VI = hypotrophie · type VII = hypotrophie

Moyen mnémotechnique : I formation, II différenciation (séparation), III duplication, IV surdéveloppement, V sous-développement, VI brides amniotiques.

PIÈGES

Clé inversée dans la banque. Une question Swanson coche « type I : défaut de différenciation », « type II : défaut de formation » et « type VI : grands syndromes » comme justes, alors que « type V : maladie amniotique » est cochée fausse. Une autre question (brides amniotiques) dit que le type I est le défaut de formation et que la maladie amniotique n'est pas le type 2. Je retiens la classification ci-dessus (I formation, II différenciation, VI amniotique) ; si l'énoncé reprend la version inversée, la clé de la banque la donne juste.

Maladie amniotique (brides amniotiques)

- Due à des **brides fibreuses** nées de la rupture de la membrane amniotique, qui compriment ou sectionnent un segment de membre.
- Diagnostic **clinique à la naissance** : **sillons de striction** (signe pathognomonique), **amputations**, **acrosyndactylie** (main en moufle).
- Diagnostic différentiel avec le **défaut de formation transversal** (type I). Ni polydactylie (duplication), ni synostose (défaut de séparation), ni ectromélie longitudinale.

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×9 **Maladie amniotique**

- ✔ Signes : **sillons**, **amputations**, **acrosyndactylies**
- ✔ Le diagnostic est posé sur la **présence de sillons** ; il est fait à la **naissance**
- ✔ Diagnostic différentiel avec le **défaut de formation transversal** (type I)
- ✔ Peut causer une acrosyndactylie (main en moufle)
- ✔ Due à des brides émanant de la membrane amniotique
- ✘ Polydactylies · synostoses
- ✘ « Est due à une membrane amniotique » (ce sont les brides, après rupture)
- ✘ Donne des ectromélies longitudinales
- ✘ Pose le diagnostic différentiel avec le défaut de **séparation**
- ✘ Nécessite **toujours** une libération en extrême urgence

Une version de la banque coche « libération de la bride en extrême urgence » juste, l'autre la coche fausse : le mot « toujours » la rend fausse.

Ectromélies et aplasies segmentaires

Anomalie	Définition
Ectromélie longitudinale latérale de la jambe	**Agénésie de la fibula (péroné)** ; dans les formes plus complètes, atteinte des deux os
Ectromélie longitudinale médiale	Agénésie du tibia ; hypoplasie de l'ulna pour l'avant-bras
Ectromélie longitudinale latérale de l'avant-bras	**Agénésie ou hypoplasie du radius** : **main botte radiale**, pouce souvent hypoplasique ou absent
Phocomélie	Aplasie segmentaire proximale d'un membre, la main étant présente et rattachée près du tronc
Amélie / péromélie	Absence totale du membre / membre terminé en moignon sans main
Synostose radio-ulnaire	Défaut de séparation : limitation de la **pronosupination** ; ostéotomie de réorientation-rotation si pronation exagérée

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×4 **Ectromélies**

- ✔ Ectromélie longitudinale latérale de jambe = **agénésie de la fibula**
- ✔ Ectromélie longitudinale latérale de l'avant-bras : agénésie/hypoplasie du **radius**, cause de la **main botte radiale**, souvent avec hypoplasie du pouce
- ✔ Aplasie segmentaire du bras avec présence de la main = **phocomélie**
- ✔ Synostose radio-ulnaire : pronation et supination limitées, pas la flexion-extension du coude
- ✘ Agénésie du tibia ou du fémur comme ectromélie **latérale** de jambe
- ✘ Ectromélie latérale de l'avant-bras = type V de Swanson
- ✘ Péromélie ou amélie pour une aplasie avec main présente

9 · Liens avec la hanche et urgences néonatales TOMBE EN QCM ×5

★★

Sujet	À retenir
Hanche à risque	Une malformation des pieds (PBVE) fait rechercher une **luxation congénitale de hanche** avec : présentation par le **siège**, **antécédent familial**, **sexe féminin**, grossesse gémellaire, doigt surnuméraire. Pas la multiparité, pas une malformation rénale
Urgences orthopédiques néonatales	**PBVE**, **torticolis congénital musculaire**, **syndactylies embryonnaires**, **ostéo-arthrite du nouveau-né** (pas la scoliose idiopathique)
Conclusion du cours	Toute anomalie du pied peut cacher une pathologie sus-jacente ; avis orthopédique pédiatrique nécessaire ; certaines malformations demandent un traitement orthopédique rapide, **idéalement dans la première semaine de vie**

10 · Fiche flash : vrai ou faux ?

Affirmation	Réponse
Le PBVE est une urgence orthopédique néonatale.	VRAI
Le PBVE associe équin, varus et adduction ; le talus en fait partie.	FAUX (talus jamais)
Le PBVE est bilatéral dans environ 49 % des cas.	VRAI
Il touche surtout les filles.	FAUX (garçons 70 %)
Il est secondaire à une maladie neuromusculaire dans environ 10 % des cas.	VRAI
La gravité s'évalue par le score de Dimeglio sur 20.	VRAI
La méthode de Ponseti associe plâtres et ténotomie d'Achille.	VRAI
Il existe un traitement médical du PBVE.	FAUX
On attend l'âge de la marche pour opérer.	FAUX
Radio de face : divergence talo-calcanéenne diminuée.	VRAI
Radio de profil : angle tibio-talien augmenté.	VRAI
Le métatarsus adductus s'associe fréquemment au PBVE et se traite chirurgicalement d'emblée.	FAUX
Le pied talus se corrige spontanément avant le 4e mois.	VRAI
Le pied convexe congénital est rare mais grave.	VRAI
La polydactylie postaxiale représente 70 % des cas.	VRAI
Swanson : type II = défaut de formation.	FAUX (différenciation)
Swanson : type VI = maladie amniotique.	VRAI
La maladie amniotique se diagnostique par les sillons.	VRAI
L'ectromélie latérale de jambe est une agénésie de la fibula.	VRAI
Un PBVE doit faire chercher une luxation de hanche.	VRAI